

REHABILITACIÓN EN REUMATOLOGÍA

**Semana 07: Reumatismo no articular –
Síndromes dolorosos de muñeca y
mano**

Lic Cesar Borja Arenas

Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitation

Docente

Presente.



Reconocer las principales características clínicas de los síndromes dolorosos de muñeca y mano más comunes y los lineamientos para el apoyo en los programas de tratamiento fisioterapéutico.

Semana 07: Reumatismo no articular – Síndromes dolorosos de muñeca y mano

1. Síndrome del túnel del carpo

- 1. Concepto y factores de riesgo**
- 2. Manifestaciones clínicas**
- 3. Objetivos y estrategias de tratamiento**

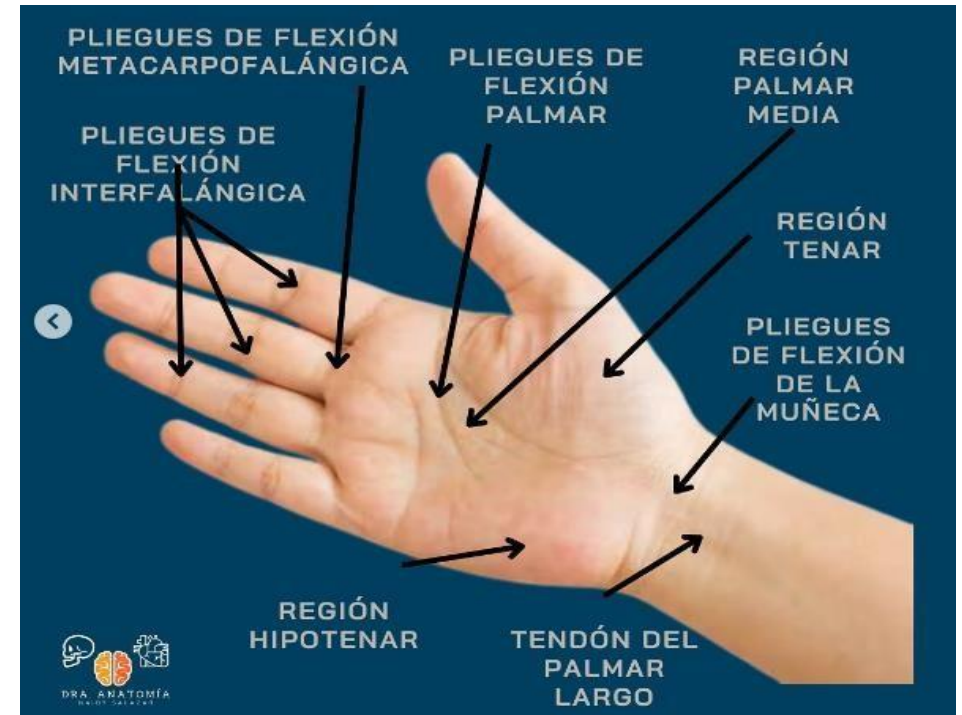
2. Tenosinovitis de Quervain

- 1. Concepto y factores de riesgo**
- 2. Manifestaciones clínicas**
- 3. Objetivos y estrategias de tratamiento**

3. Tenosinovitis estenosante

- 1. Concepto y factores de riesgo**
- 2. Manifestaciones clínicas**
- 3. Objetivos y estrategias de tratamiento**

Presente.

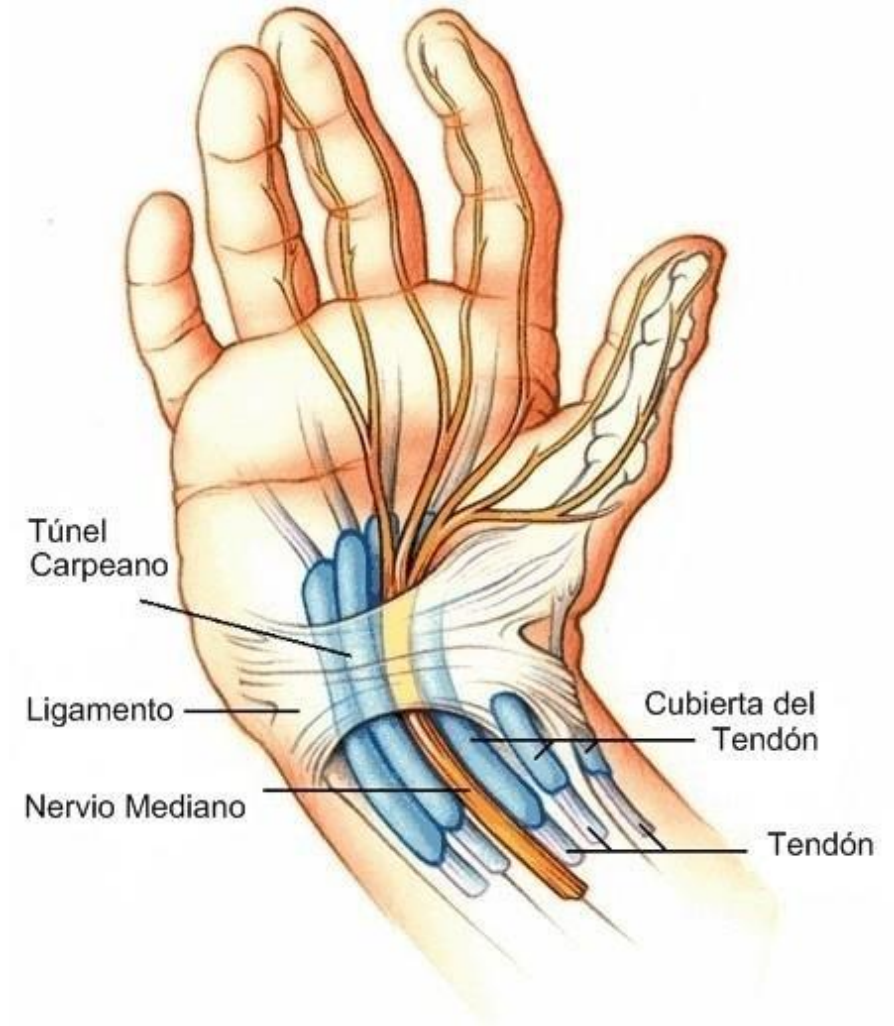


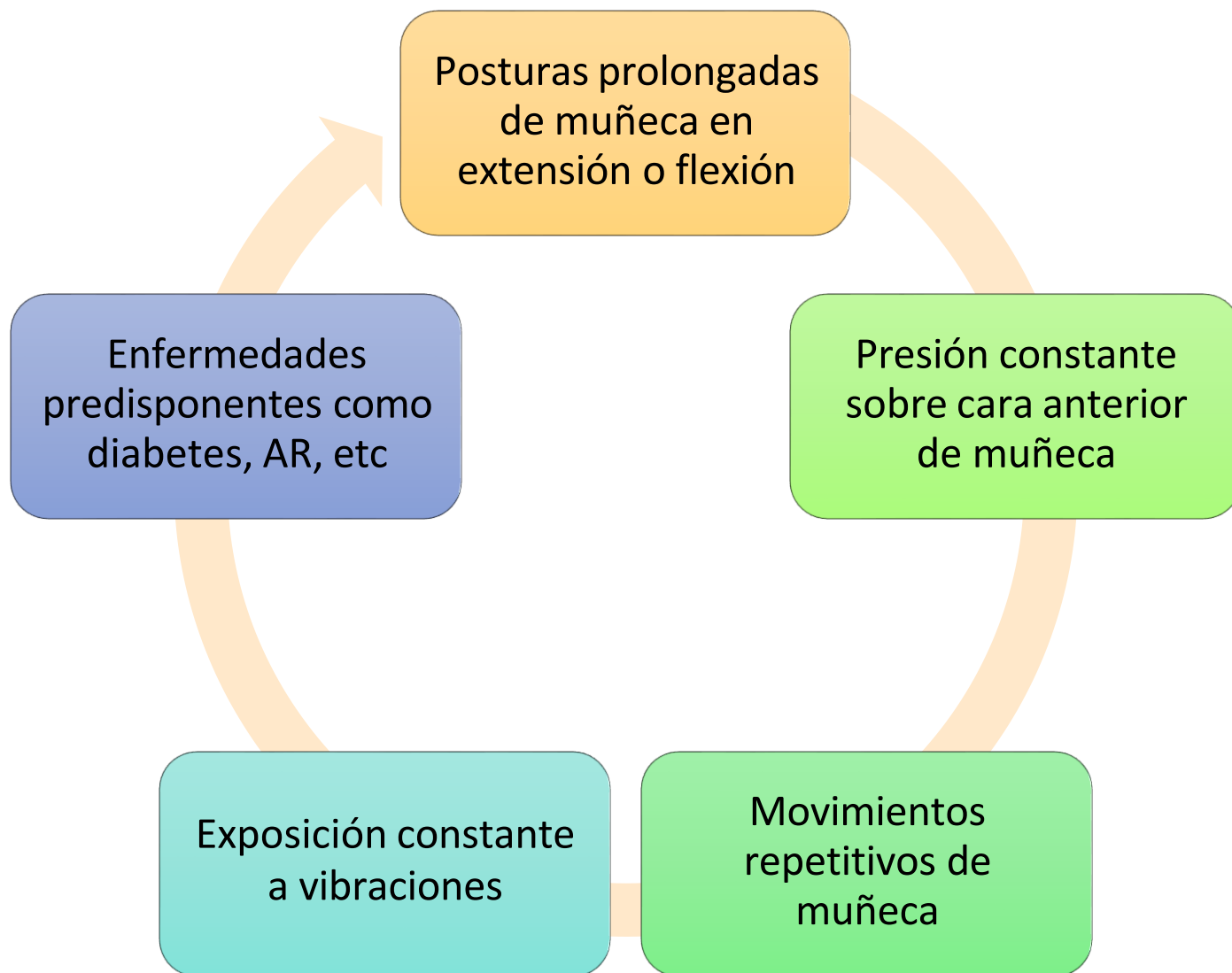
¿QUÉ FUNCIONES TIENE LA MANO?

SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO



Neuropatía compresiva sintomática del nervio mediano por distorsión mecánica paulatina.





Dolor neuropático y mecánico a nivel de la cara anterior de muñeca, mano y dedos (excepto el meñique)

Parestesias en muñeca, palma y en dedos inervados: pulgar, índice, medio y mitad de anular

Hipotrofia de musculatura tenar asociado a disminución de fuerza en mano y muñeca

Disminución de la destreza manual para actividades de la vida diaria



Control del dolor e inflamación

Termoterapia en musculatura flexora de muñeca y mano

Ultrasonido o láser terapéutico sobre retináculo

Electroterapia sobre musculatura flexora de muñeca y mano y en puntos de dolor



Aumento de rango articular

Masoterapia sobre musculatura con mayor tono (flexores)

Estiramientos musculares para flexores de muñeca y mano y para musculatura del pulgar

Movimientos activos de muñeca (sobre todo la flexo extensión)



Aumento de fuerza muscular

Isométricos para extensión y flexión de muñeca y para cierre manual

Isotónicos resistidos para extensión y flexión de muñeca y para cierre manual (pesas o bandas)

Apoyo y carga de peso progresiva sobre la muñeca extendida



Incremento de la funcionalidad

Potenciación del cierre y apertura manual

Ejercicios de oposición de dedos y pinzas

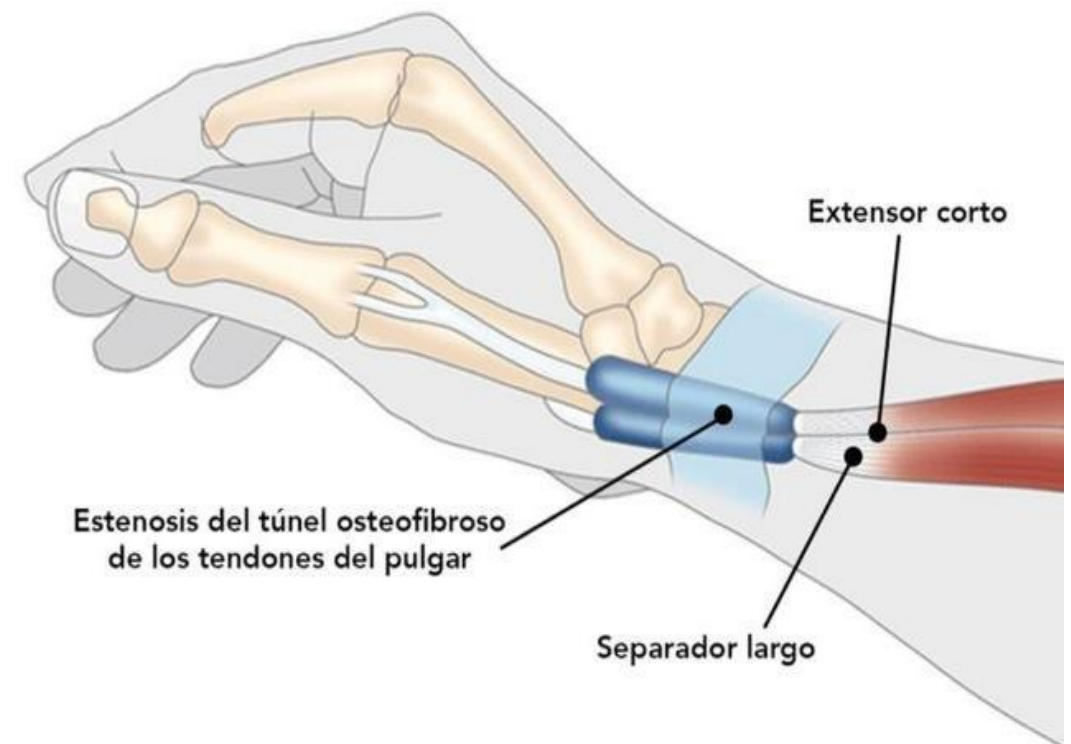
Actividades funcionales según las labores que cumpla el paciente



TENOSINOVITIS DE QUERVAIN



Inflamación de los tendones abductor largo y extensor corto del dedo pulgar y de la vaina tendinosa que los recubre ocasionado con frecuencia por estímulos mecánicos.



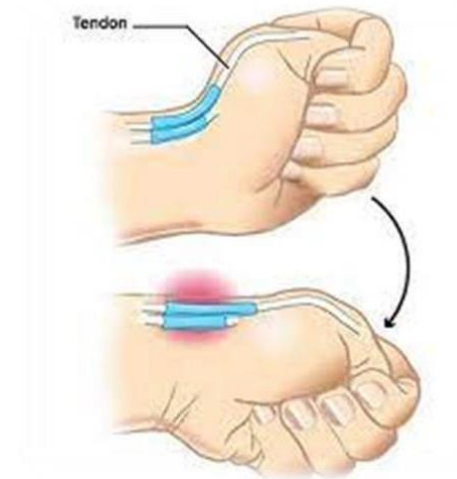


Dolor mecánico en el lado radial de la muñeca (tabaquera anatómica) y en zona tenar

Posible tumefacción por inflamación en zona tendinosa

Aumento de tono muscular de extensores de muñeca y mano

Dificultad para realizar pinzas, movimientos del pulgar y, sobre todo, desviación cubital



Control del dolor e inflamación

Termoterapia en musculatura extensora de muñeca y mano

Ultrasonido o láser terapéutico sobre zona tendinosa (tabaquera anatómica)

Electroterapia sobre musculatura extensora de muñeca y mano y en puntos de dolor



Aumento de rango articular

Masoterapia sobre musculatura con mayor tono (extensores de muñeca y aductor del pulgar)

Estiramientos musculares para extensores de muñeca y mano y para musculatura del pulgar

Movimientos activos de muñeca (sobre todo las desviaciones)



Aumento de fuerza muscular

Isométricos para movimientos de muñeca y para cierre manual

Isotónicos resistidos para movimientos de muñeca y para cierre manual (pesas o bandas)

Apertura manual con resistencia



Incremento de la funcionalidad

Potenciación del cierre y apertura manual

Ejercicios de oposición de dedos y pinzas

Actividades funcionales según las labores que cumpla el paciente

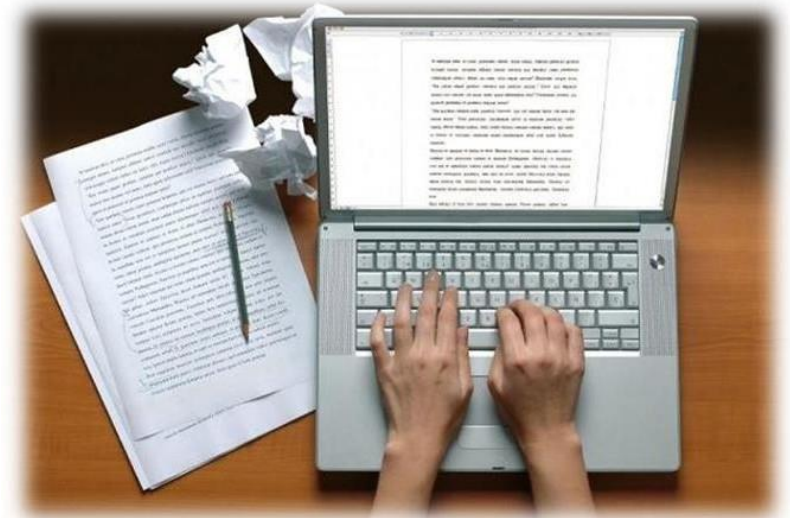
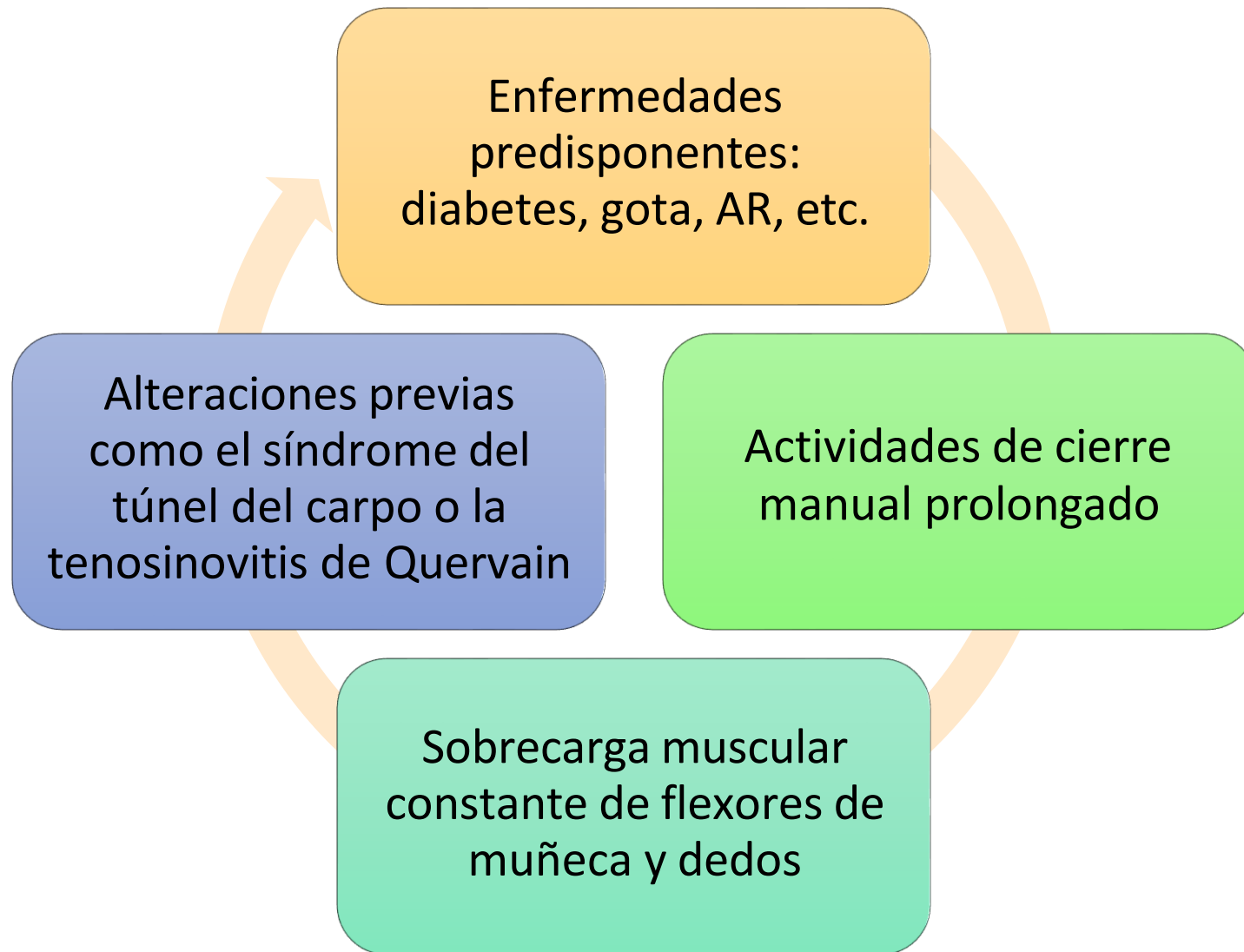


TENOSINOVITIS ESTENOSANTE



Atrapamiento y/o pinzamiento mecánico de los tendones flexores de dedos al pasar por la polea retinacular a la altura de la cabeza metacarpiana (polea 1).





Dolor mecánico al extender el dedo comprometido (acompañado de chasquido)

Posible aparición de nódulo palpable y doloroso a la presión a nivel de la cabeza del metacarpo afectado

Bloqueo y rigidez de la articulación metacarpofalángica afectada en posición de flexión

Dificultad para las praxias manuales debido al dolor y bloqueo



Control del dolor e inflamación

Termoterapia en musculatura flexora de muñeca y mano

Ultrasonido o láser terapéutico sobre zona tendinosa (polea afectada)

Electroterapia sobre musculatura flexora de muñeca y mano y en puntos de dolor

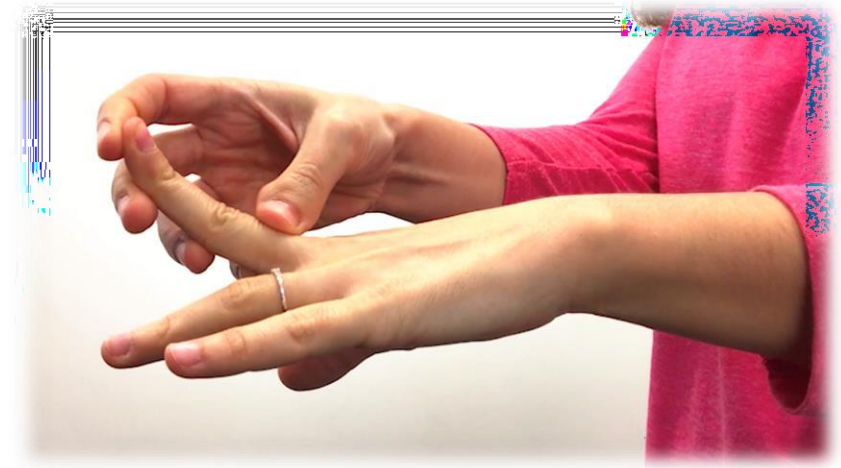


Aumento de rango articular

Masoterapia sobre musculatura con mayor tono (fascia palmar y flexores de dedos)

Estiramientos musculares para flexores de muñeca y dedos

Movimientos activos del dedo afectado

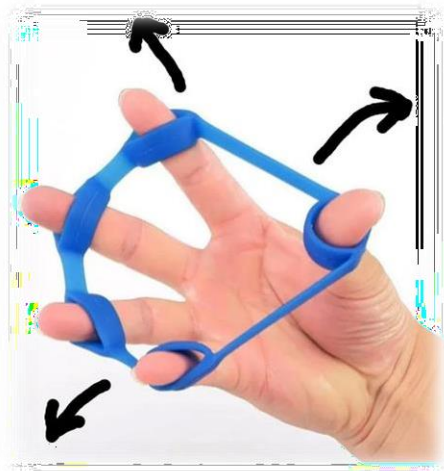


Aumento de fuerza muscular

Isométricos para cierre manual

Isotónicos para extensores de dedos (sobre todo el afectado)

Apertura manual con resistencia

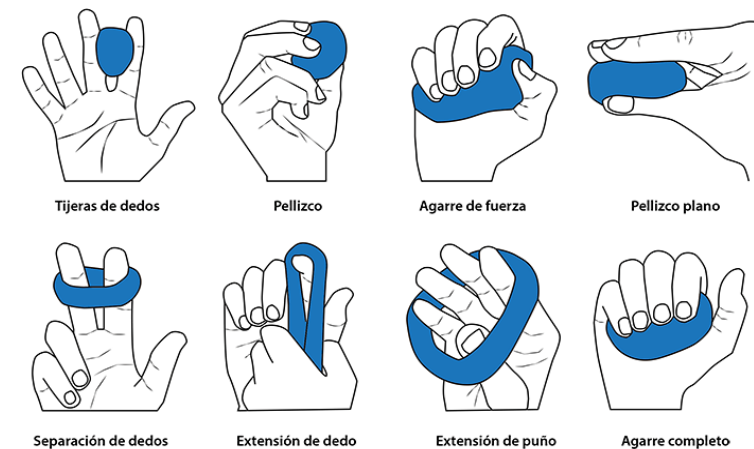


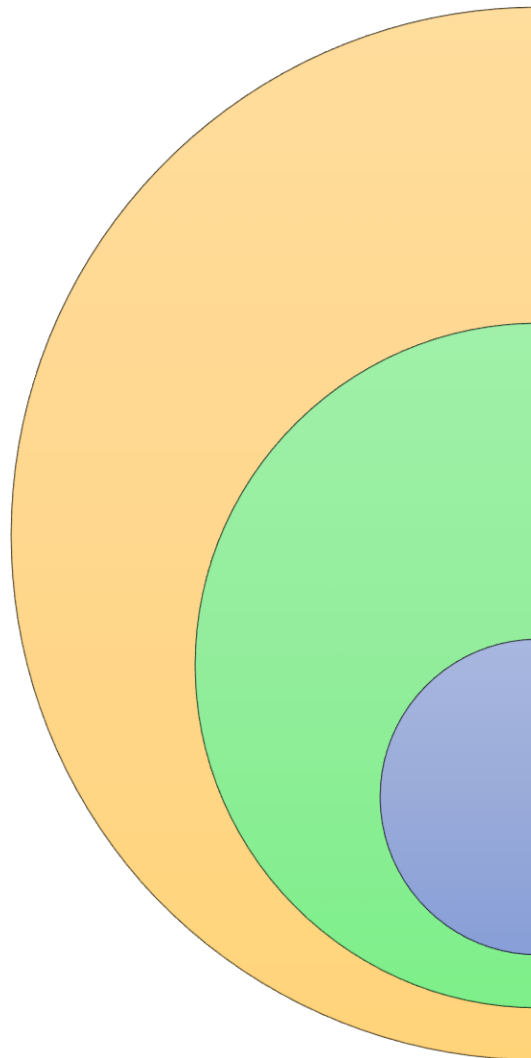
Incremento de la funcionalidad

Potenciación del cierre y apertura manual

Ejercicios de oposición de dedos y pinzas

Actividades funcionales según las labores que cumpla el paciente





1. El Síndrome del túnel del carpo es una neuropatía compresiva sintomática del nervio mediano por distorsión mecánica paulatina.
2. La tenosinovitis de Quervain es una inflamación de los tendones abductor largo y extensor corto del dedo pulgar y de la vaina tendinosa que los recubre ocasionado con frecuencia por estímulos mecánicos.
3. La tenosinovitis estenosante es el atrapamiento y/o pinzamiento mecánico de los tendones flexores de dedos al pasar por la polea retinacular a la altura de la cabeza metacarpiana (polea 1).

- <https://www.medigraphic.com/pdfs/orthotips/ot-2014/ot141g.pdf>
- http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2014000500010
- <https://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2012/ane124i.pdf>
- <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0037-1606751.pdf>
- http://www.revmedmaule.cl/wp-content/uploads/2020/12/Vol34_N2_CAPITULO9.pdf
- <https://www.medigraphic.com/pdfs/actmed/am-2020/am204p.pdf>

Presente.





PREGUNTAS O INTERVENCIONES



EP1

A continuación realizaremos la primera evaluación del proceso del curso. Para ello, debe asegurarse de tener buena conexión a internet y de preferencia responda desde una laptop o computadora.

Tiempo: 60 minutos.

MUCHAS GRACIAS

Presente.